# 움직이면 나아지는 허리 통증 — 척추관절염을 확인할 때

허리 통증은 아주 흔하고 그중 척추관절염은 일부입니다. 서서히 시작해 아침에 심하고 움직이면 나아지는 **통증의 양상**과, 의심될 때 쓰는 **HLA-B27 검사**를 읽는 법을 자가항체 검사 강의에서 설명한 내용으로 정리했습니다.

## 허리 통증, 대부분은 척추관절염이 아닙니다

살면서 허리 통증을 겪는 사람
**80% 이상**
누구나 한 번쯤 겪습니다

만성 허리 통증 중 축성 척추관절염
**5% 미만**
그래서 양상을 잘 살펴봅니다

염증성 허리 통증 양상: 놓치지 않는 비율 (민감도) · 가려내는 비율(특이도)
**75~80% · 25~44%**
양상만으로는 구별에 한계가 있습니다

## 염증성 허리 통증은 하루 이렇게 흐릅니다



**아침**
일어났을 때 가장 뻣뻣하고 아픕니다

**낮**
움직이고 활동하면 나아지고, 쉬어도 좋아지지 않습니다

**밤**
나빠져서 자다가 깹니다

## 통증의 양상 — 이런 점을 진료 때 알려 주세요

**척추관절염을 의심하게 하는 양상**

- **비교적 젊은 나이**(기준표에서는 40세 이전)에 시작
- **3개월 이상** 이어지는 만성 통증
- **서서히** 시작해 뚜렷한 시작일이 없음
- **아침에 일어났을 때 뻣뻣하고 많이 아픔**, 오래 앉아 있어도 아픔
- **움직이고 활동하면 좋아지고** 쉬어도 좋아지지 않음
- **밤에 나빠져 자다가 깸**, 엉덩이 통증이 좌우 번갈아 나타남

**양상이 다른 경우와 참고할 점**

- 어느 날 **갑자기** 아팠고, 움직이고 활동하거나 **오래 서 있으면 더 아프다**면 양상이 다릅니다.
- 의사는 위 항목 중 몇 개가 해당하는지로 판단합니다(기준표에 따라 5개 중 4개, 4개 중 2개 등).
- 소염진통제(NSAID)를 충분량 쓴 뒤 **24~48시간 안에 좋아지는지**도 참고하지만 완벽한 구별법은 아닙니다. 용량은 진료에서 정합니다.

## 척추관절염이라면 허리 밖에서도 신호가 있습니다

**엉덩이뼈와 척추 사이 관절**
천장관절과 척추에 염증이 생깁니다.

**무릎·발목 등 팔다리 관절**
말초 관절에도 염증이 올 수 있습니다.

**힘줄이 뼈에 붙는 곳**
아킬레스건 부위가 붓고 아픕니다(부착부염).

**건선**
피부 건선이 함께 있을 수 있습니다.

**염증성 장질환**
장의 염증 질환이 함께 있을 수 있습니다.

**포도막염**
눈 속 염증이 동반될 수 있습니다.

이런 양상이 있을 때 HLA-B27 검사를 해 보면 진단에 도움이 된다고 강의에서 설명했습니다(다음 쪽).

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

**출처** · 아산 28회 연수강좌 — 자가항체 검사 해석의 핵심 포인트(홍석찬)

*본 자료는 일반 안내입니다. 허리 통증의 원인은 다양하니 이 자료만으로 스스로 판단하지 마시고, 궁금한 점은 진료 때 물어보세요.*

# HLA-B27 검사, 이렇게 읽습니다

HLA-B27은 항체가 아니라 유전적 표지 검사입니다. 척추관절염이 의심될 때에만 의미가 있고, 건강한 사람에게 미리 해 보는 검사는 아닙니다.

## HLA-B27 결과의 의미

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| HLA-B27이란 | 면역과 관련된 HLA class I 유전자군의 하나로, 핵이 있는 세포와 혈소판 등 적혈구를 뺀 거의 모든 세포에 나타납니다. 항체를 찾는 검사가 아니라 **유전적 표지**를 보는 검사입니다. |
| 척추관절염(축성 척추관절염·강직성 척추염) 환자 | **74~89%**에서 HLA-B27이 양성입니다. 일반 인구에서는 **1% 미만**이라 척추관절염을 의심하는 데 도움이 됩니다. |
| HLA-B27이 양성인 사람 | 평생 척추관절염이 생길 위험은 **2~10%(약 5%)**입니다. 양성이라고 해서 대부분 병이 생기는 것은 아닙니다. |
| 누구에게 검사하나요 | **척추관절염이 의심되는 상황**에서만 의미가 있습니다. 일반 인구에서 선별 목적으로 하는 것은 **권고되지 않습니다.** |
| 류마티스 인자(RF)와의 관계 | 류마티스 인자는 강직성 척추염에서 **15% 미만**, 건선관절염에서는 **음성**입니다. 류마티스 인자 검사와는 목적이 다릅니다. |

연자는 혈액검사를 **목적이 뚜렷할 때, 임상 상황 안에서** 해야 하며 완벽한 검사는 없다고 정리했습니다. 일반 인구에서 무작정 검사하면 항핵항체·ANCA도 10% 이상에서 양성으로 나옵니다.

## 염증성 허리 통증 기준표의 한계 (강의 소개)

| 기준표 | 염증성 허리 통증으로 보는 조건 | 놓치지 않는 비율(민감도) | 가려내는 비율(특이도) |
|---|---|---|---|
| Calin | 5개 중 4개 | **89.6%** | 52.5% |
| Rudwaleit | 4개 중 2개 | 70.3% | **81.4%** |
| ASAS | 5개 중 4개 | 79.6% | 72.4% |

어느 기준표든 한쪽이 높으면 다른 쪽이 낮아 **양상만으로 확정하기는 어렵습니다.**

## 연수강좌 질의응답에서 연자가 답한 내용

### 반복되는 포도막염

다른 증상이 뚜렷하지 않아도 드물게 천장관절 X-ray에서 강직성 척추염이 진단됩니다. HLA-B27 검사와 천장관절 X-ray가 도움이 된다고 답했습니다.

### 건선과 관절염

건선관절염은 류마티스 인자(RF)와 항CCP 항체가 음성인 것이 특징이라고 답했습니다.

### 관절이 붓는 경우

가장 중요한 단서는 **관절 부종**입니다. 6주 이상 붓는다면 RF·항CCP 항체가 정상이어도 류마티스내과 진료가 필요하다고 답했습니다.

### 항CCP 항체 수치가 달라질 때

항CCP 항체는 역가(수치)가 변할 수 있어, 임상 증상이 달라지면 추적 관찰이 필요하다고 답했습니다.

### 항핵항체 1:80이 나온 경우

1:80은 낮은 역가로 보며, 레이노 현상이나 관절염 같은 증상이 없다면 굳이 추적 검사를 할 이유가 없다고 답했습니다.

### 자가면역질환의 경과

류마티스 관절염, 전신홍반루푸스처럼 온몸을 침범하는 자가면역질환은 기본적으로 만성적이고 재발을 반복하는 경과를 보인다고 답했습니다.

## 정리하면

### 이럴 때는 진료 때 꼭 말씀해 주세요

- 허리 통증이 **3개월 이상** 이어지고, **아침에 뻣뻣하며 움직이면 나아지고 밤에 깨는** 양상일 때
- 허리 통증과 함께 **반복되는 눈 염증(포도막염)**, 건선, 아킬레스건 부위의 붓기, 염증성 장질환이 있을 때
- 손가락·무릎 등 **관절이 6주 이상 붓는** 경우 — 류마티스 피검사가 정상이어도 진료가 필요합니다

궁금한 점은 진료 때 물어보세요.

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진
**출처** · 아산 28회 연수강좌 — 자가항체 검사 해석의 핵심 포인트(홍석찬)

*본 자료는 일반 안내입니다. 허리 통증의 원인은 다양하니 이 자료만으로 스스로 판단하지 마시고, 궁금한 점은 진료 때 물어보세요.*

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/musculoskeletal/asl28-inflammatory-back-pain/